جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هناء عبدالعزيز عبدالرحمن محمد

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** 8 ح مرسي سليم - خلف مدرسه ام المومنين

رقم البطاقة : 28806030103068 **رقم التليفون :** 01100367631 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 03-06-1988 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي محوسب مع صبغة للرقبة والصدر والبطن والحوض [11128] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هناء عبدالعزيز عبدالرحمن محمد
National ID: 28806030103068

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT scan of the neck, chest, abdomen, and pelvis.**

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هناء
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد
٨ح مرسى سليم خلف مدرسة أم المؤمنين
الساحل - القاهره

٢٨٨٠٦٠٣٠١٠٣٠٦٨

IK8959726

٣٩٦٧
٢٠٢٦

٢٨٨٠٦٠٣٠١٠٣٠٦٨ ٢٠٢٠/٠٦
بكالوريوس نظم معلومات ادارية

أنثى مسلمة متزوجة
محمد يسرى احمد مصطفى
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٦/١٩

[[DOCTYPE:PATHOLOGY REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترتالثوتل – مصر-معمل الباثولوجي

جوستاف روسي

Patient Name	هناء عبد العزيز عبدالرحمن	**Case No.**	**438677**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**30700**
Registered Date	**01/10/2026 11:26:41 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**06/10/2026 09:11:45 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:39:10 AM**	**Pathology No.**	**3130/26**

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 4c).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 28/09/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Five fragmented grayish, white tissue cores, ranging in length from 0.5 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Microcalcification:** Absent.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent.
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.
- **Additional Pathological Findings:** Focal necrosis.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 25% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Strong membrane staining in more than 10% of the tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 35%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).

CAP ACCREDITED

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

{{DOCTYPE:PATHOLOGY REPORT}}
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	هناء عبد العزيز عبدالرحمن	**Case No.**	**438677**
Sex/Age	**Female 38 Y**	**Patient No.**	**30700**
Registered Date	**01/10/2026 11:26:41 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**06/10/2026 09:11:45 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:39:10 AM**	**Pathology No.**	**3130/26**

- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67%: 35%.

***Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
** ***Scoring system: "Her2"***
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

Hanaa Abd Alaziz Abd Alrahman :اسم المريض بالإنجليزية	كود المريض: 100824
2026/09/23 10:13:58 AM :تاريخ التقرير	السن: ٣٨ سنة, ٣ شهر

Women's Health Outreach Program
Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: Right breast hard mass.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Almost fatty parenchyma (ACR A)
- UOQ posterior third dense irregular mass about 6.5cm from the nipple
- No suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated a corresponding multiple interconnected hypoechoic solid masses seen at 10:00 outer zone (c), reaching up to 3mm from the overlying skin, measuring 37x22mm. High internal vascular signal was depicted by color Doppler study
- Small similar hypoechoic rather oval nodule seen in the same axis about 5.8mm anterior to the aforementioned mass measuring 11.2x10mm and being about 11mm from the skin
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Apart from solitary pathological lymph node showing 6.5mm focal cortical thickening, other nodes are non -specific axillary LNs.

Left breast

- Almost fatty parenchyma (ACR A)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** confirmed no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 4c): UOQ highly suspicious mass lesions

Left breast (BI-RADS 1): Normal Study

Recommendations:

Tissue biopsy for histopathological assessment.

Best regards,
Dr. Eman Ali



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هناء
عبدالعزيز عبدالرحمن محمد
٨ح مرسى سليم-خلف مدرسة أم المؤمنين
الساحل - القاهره

١٩٨٨/٠٦/٢٩٣

٢٨٨٠٦٠٣٠١٠٣٠٦٨

IK8959726

-١١-٣٦٧٦٣١

عبد



٢٨٨٠٦٠٣٠١٠٣٠٦٨ ٢٠٢٠/٠٦

بكالوريوس نظم معلومات ادارية

انثى مسلمة متزوجة

محمد يسرى احمد مصطفى

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٦/١٩

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Hanaa Abd Alaziz Abd Alrahman :اسم المريض بالإنجليزية	100824 :كود المريض
2026/09/23 10:13:58 AM :تاريخ التقرير	السن: ٣٨ سنة, ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: Right breast hard mass.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Almost fatty parenchyma (ACR A)
- UOQ posterior third dense irregular mass about 6.5cm from the nipple
- No suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated a corresponding multiple interconnected hypoechoic solid masses seen at 10:00 outer zone (c), reaching up to 3mm from the overlying skin, measuring 37x22mm. High internal vascular signal was depicted by color Doppler study
- Small similar hypoechoic rather oval nodule seen in the same axis about 5.8mm anterior to the aforementioned mass measuring 11.2x10mm and being about 11mm from the skin
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Apart from solitary pathological lymph node showing 6.5mm focal cortical thickening, other nodes are non -specific axillary LNs.

Left breast

- Almost fatty parenchyma (ACR A)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Ultrasound** confirmed no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 4c): UOQ highly suspicious mass lesions

Left breast (BI-RADS 1): Normal Study

Recommendations:

Tissue biopsy for histopathological assessment.

Best regards,
Dr. Eman Ali

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :2026-9-23 جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) هناء عبدالعزيز عبدالرحمن بطاقة رقم 28806030103068

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :2026-9-23

الموظف المختص

محمود عبدالله

٥٦٥٦٣

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،

مسلسل 2087964

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]